CAC
Cuenta de Alto Costo

8

Melanoma

RESUMEN infográfico

Melanoma

8

2 de enero de 2024 al 1° de enero de 2025

Morbimortalidad del melanoma

Ocupó el **octavo lugar** entre las neoplasias priorizadas y representó el 3,28 % de los casos nuevos notificados durante el periodo.

Se notificaron **690 casos nuevos invasivos,** lo que corresponde a una PCNR estandarizada de 1,14 casos nuevos por 100.000 habitantes (IC 95 %: 1,06 - 1,23).

Se registraron **563 muertes en personas** con melanoma invasivo, lo que corresponde a una mortalidad general estandarizada de 0,89 por 100.000 habitantes (IC 95 %: 0,82 - 0,97).

El número total de casos nuevos, tumores registrados y fallecidos fue de 1.127, 12.265 y 632, respectivamente (incluye tumores *in situ* e invasivos).

Caracterización de los casos nuevos de melanoma

El 53,33 % correspondió al sexo femenino.

La mediana de edad fue de 65 años (RIC: 53 - 75).

El 70,28 % de los casos recibió algún tratamiento.

Evaluación de la gestión del riesgo en los casos de melanoma cutáneo

La proporción nacional de casos diagnosticados en estadios I y II fue de 65,79 %, por encima de la meta de alto cumplimiento establecida (> 50 %).

El régimen subsidiado presentó el **menor tiempo promedio** para la confirmación diagnóstica **(17,07 días).**

Descargar infografía

PCNR: proporción de casos nuevos reportados.
IC: intervalo de confianza.
RIC: rango intercuartílico.

8. Melanoma

CIE-10: C43 Y D03; CIE-O-3: C44

8.1. Morbimortalidad del melanoma

De las neoplasias de mayor frecuencia notificadas a la CAC, el melanoma ocupó el octavo lugar representando el 3,28 % del total de los casos nuevos durante el periodo. Incluyendo tanto tumores *in situ* como invasivos, fueron reportados 12.265 neoplasias de este tipo, de las cuales el 9,19 % (n= 1.127) correspondió a CNR. En cuanto a la mortalidad, se registraron 632 defunciones por todas las causas en lesiones *in situ* e invasivas. Se resalta que las medidas de morbimortalidad se calcularon incluyendo únicamente los casos invasivos y se presentan en la **tabla 8.1.**

Tabla 8.1. Medidas de frecuencia del melanoma en el marco del aseguramiento, Colombia 2025

Medida	Casos[1]	Medida cruda[2,3]	Medida estandarizada[3,4]	IC 95 %[5]
PCNR	690	1,31	1,14	(1,06 - 1,23)
Prevalencia	8.269	15,72	13,61	(13,32 - 13,91)
Mortalidad[6]	563	1,07	0,89	(0,82 - 0,97)

[1] Incluye todos los casos de melanoma invasivo de la cohorte en seguimiento por la CAC.
[2] Informadas por 100.000 habitantes.
[3] La población de referencia corresponde a la proyectada por el DANE para el año 2024.
[4] Estandarización por la edad calculada con método directo. La población de referencia correspondió a la estándar mundial por grupos quinquenales de edad, definida por la OMS.
[5] IC 95 % para las medidas estandarizadas.
[6] **Mortalidad general:** corresponde a los casos fallecidos por todas las causas reportados a la CAC.
PCNR: proporción de casos nuevos reportados; **IC:** intervalo de confianza.

8.1.1. PCNR de melanoma según la región y la entidad territorial

La región del país con la PCNR estandarizada más elevada fue Bogotá, D. C., y aquella con la cifra más baja fue Amazonía-Orinoquía **(tabla 8.2).** En cuanto a las entidades territoriales, la mayor proporción se observó en Risaralda con 1,91 casos de melanoma invasivo por cada 100.000 habitantes (IC 95 %: 1,21 - 2,90), seguida de Bogotá, D. C. En contaste, la cifra más baja se presentó en Córdoba con 0,16 CNR (IC 95 %: 0,03 - 0,47). Adicionalmente, en siete departamentos no se informaron casos nuevos durante el periodo.

Para conocer esta información con mayor desagregación, le invitamos a consultar HIGIA.

Tabla 8.2. PCNR de melanoma según la región de residencia en el marco del aseguramiento, Colombia 2025

Región	CNR[1]	Denominador[2]	PCNR cruda[3]	PCNR estandarizada[3,4]	IC 95 %[5]
Amazonía-Orinoquía	2	1.544.639	0,13	0,15	(0,02 - 0,53)
Bogotá, D. C.	173	7.918.660	2,18	1,82	(1,56 - 2,12)
Caribe	55	12.130.521	0,45	0,46	(0,35 - 0,60)
Central	238	12.486.760	1,91	1,56	(1,36 - 1,77)
Oriental	120	9.966.135	1,20	1,01	(0,83 - 1,21)
Pacífica	102	8.567.038	1,19	0,97	(0,79 - 1,18)
Nacional	**690**	**52.613.753**	**1,31**	**1,14**	**(1,06 - 1,23)**

[1] Incluye todos los casos nuevos de melanoma invasivo de la cohorte en seguimiento por la CAC.
[2] Corresponde a la población proyectada por el DANE para el año 2024.
[3] Informadas por 100.000 habitantes.
[4] Estandarización por la edad calculada con método directo. La población de referencia correspondió a la estándar mundial por grupos quinquenales de edad, definida por la OMS.
[5] IC 95 % para las medidas estandarizadas.
PCNR: proporción de casos nuevos reportados; **IC:** intervalo de confianza.

8.1.2. PCNR de melanoma según el régimen del aseguramiento y la entidad aseguradora

Como se observa en la **tabla 8.3,** en el régimen contributivo se observa una PCNR de 1,39 casos por 100.000 afiliados, la cual fue significativamente mayor que en el subsidiado y el especial. En cuanto a las entidades aseguradoras, la proporción más alta se evidenció en la EPS046 con 3,96 casos nuevos por 100.000 afiliados. Por el contrario, la más baja fue identificada en la EPSS41 con 0,38 casos por 100.000 afiliados. De este mismo grupo de regímenes, ocho EAPB no reportaron casos para este periodo de análisis, de las cuales cinco fueron del subsidiado.

La información completa de las EAPB está disponible en HIGIA.

Tabla 8.3. PCNR de melanoma según el régimen del aseguramiento, Colombia 2025

Régimen	CNR[1]	Denominador[2]	PCNR cruda[3]	PCNR estandarizada[3,4]	IC 95 %[5]
Contributivo	503	28.511.097	1,76	1,39	(1,27 - 1,52)
Subsidiado	161	20.558.122	0,78	0,63	(0,53 - 0,74)
Excepción	22	2.096.836	1,05	0,66	(0,41 - 1,05)
Especial	4	40.687	9,83	3,62	(0,63 - 31,26)
No asegurado	0	SD	SD	SD	SD
Planes voluntarios de salud	0	SD	SD	SD	SD

[1] Incluye todos los casos nuevos de melanoma invasivo de la cohorte en seguimiento por la CAC.
[2] Corresponde a la población de la BDUA con corte al 30 de junio de 2024.
[3] Informada por 100.000 afiliados.
[4] Estandarización por la edad calculada con método directo. La población de referencia correspondió a la estándar mundial por grupos quinquenales de edad, definida por la OMS.
[5] IC 95 % para las medidas estandarizadas.
En la población no asegurada y en la reportada por los planes voluntarios de salud, no se cuenta con la información para establecer el denominador, por lo cual solamente se presenta el número de CNR.
CNR: casos nuevos reportados; **PCNR:** proporción de casos nuevos reportados; **IC:** intervalo de confianza; **SD:** sin dato.

8.1.3. Prevalencia del melanoma según la región y la entidad territorial

Para este periodo, Bogotá, D. C., presentó la prevalencia estandarizada más alta, valor equivalente a 1,53 veces más el valor del país; mientras que la más baja se observó en la región Caribe **(tabla 8.4).** Entre las entidades territoriales, Risaralda tuvo la mayor prevalencia observada, con 25,07 casos por 100.000 habitantes (IC 95 %: 22,40 - 28,00). En contraste, la más baja fue identificada en La Guajira con 2,20 (IC 95 %: 1,23 - 3,58).

Para conocer esta información con mayor desagregación, le invitamos a consultar HIGIA.

Tabla 8.4. Prevalencia del melanoma según la región de residencia en el marco del aseguramiento, Colombia 2025

Región	Casos[1]	Denominador[2]	Prevalencia cruda[3]	Prevalencia estandarizada[3,4]	IC 95 %[5]
Amazonía-Orinoquía	77	1.544.639	4,98	6,17	(4,86 - 7,71)
Bogotá, D. C.	1.948	7.918.660	25,02	20,80	(19,89 - 21,74)
Caribe	489	12.130.521	4,13	4,20	(3,84 - 4,58)
Central	3.188	12.486.760	25,88	20,76	(20,04 - 21,50)
Oriental	1.270	9.966.135	12,94	10,94	(10,35 - 11,56)
Pacífica	1.177	8.567.038	13,88	11,27	(10,63 - 11,94)
Nacional	**8.269**	**52.613.753**	**15,72**	**13,61**	**(13,32 - 13,91)**

[1] Incluye todos los casos de melanoma invasivo de la cohorte en seguimiento por la CAC.
[2] Corresponde a la población proyectada por el DANE para el año 2024.
[3] Informada por 100.000 habitantes.
[4] Estandarización por la edad calculada con método directo. La población de referencia correspondió a la estándar mundial por grupos quinquenales de edad, definida por la OMS.
[5] IC 95 % para las medidas estandarizadas.
IC: intervalo de confianza.

8.1.4. Prevalencia del melanoma según el régimen del aseguramiento y la entidad aseguradora

Según el régimen de aseguramiento, la prevalencia del contributivo fue significativamente mayor a la del subsidiado **(tabla 8.5).** Por su parte, la EPS001 registró la mayor tasa, con 30,18 casos por 100.000 habitantes, mientras que la EPSI04 presentó la cifra más baja, con 0,94. Para este periodo, todas las entidades aseguradoras notificaron casos prevalentes de este tipo de neoplasia.

La información completa de las EAPB está disponible en **HIGIA**.

Tabla 8.5. Prevalencia del melanoma según el régimen del aseguramiento, Colombia 2025

Régimen	Casos[1]	Denominador[2]	Prevalencia cruda[3]	Prevalencia estandarizada[3,4]	IC 95 %[5]
Contributivo	5.813	28.511.097	20,39	15,84	(15,43 - 16,25)
Subsidiado	1.883	20.558.122	9,16	7,28	(6,95 - 7,62)
Excepción	406	2.096.836	19,36	12,00	(10,82 - 13,29)
Especial	28	40.687	68,82	34,54	(12,27 - 78,40)
Planes voluntarios de salud	14	SD	SD	SD	SD
No asegurado	5	SD	SD	SD	SD
Entidades liquidadas	120	SD	SD	SD	SD

[1] Incluye todos los casos de melanoma invasivo de la cohorte en seguimiento por la CAC.
[2] Corresponde a la población de la BDUA con corte al 30 de junio de 2024.
[3] Informada por 100.000 afiliados.
[4] Estandarización por la edad calculada con método directo. La población de referencia correspondió a la estándar mundial por grupos quinquenales de edad, definida por la OMS.
[5] IC 95 % para las medidas estandarizadas.
En la población no asegurada, los planes voluntarios de salud y las entidades liquidadas, no se cuenta con la información para establecer el denominador, por lo cual solamente se presenta el número de casos notificados.
IC: intervalo de confianza; **SD:** sin dato.

8.1.5. Mortalidad en las personas con melanoma según la región y la entidad territorial

En la cohorte en seguimiento, la mayoría de las regiones presentaron una mortalidad general estandarizada inferior a la calculada en el país. La más baja la obtuvo la Amazonía-Orinoquía, mientras que la más alta se presentó en la Central **(tabla 8.6).** Entre estas dos regiones, se estableció una diferencia absoluta de 0,91 defunciones por todas las causas por 100.000 habitantes, y la diferencia relativa fue de 3,76 veces.

Por otro lado, en el departamento del Magdalena se registró la mortalidad general más baja con 0,28 fallecimientos por 100.000 habitantes (IC 95 %: 0,08 - 0,72), mientras que Antioquia presentó la más alta, con 1,40 (IC 95 %: 1,17 - 1,68). Durante el periodo de análisis, el 24,24 % de los 33 departamentos del país no presentó muertes por todas las causas en pacientes con melanoma.

Para conocer esta información con mayor desagregación, le invitamos a consultar HIGIA.

Tabla 8.6. Mortalidad general estandarizada del melanoma según la región de residencia en el marco del aseguramiento, Colombia 2025

Región	Casos[1]	Denominador[2]	Mortalidad cruda[3]	Mortalidad estandarizada[3,4]	IC 95 %[5]
Amazonía-Orinoquía	4	1.544.639	0,26	0,33	(0,09 -0,83)
Bogotá, D. C.	111	7.918.660	1,40	1,14	(0,94 - 1,38)
Caribe	53	12.130.521	0,44	0,44	(0,33 - 0,57)
Central	207	12.486.760	1,66	1,24	(1,07 - 1,43)
Oriental	106	9.966.135	1,06	0,88	(0,72 - 1,06)
Pacífica	82	8.567.038	0,96	0,72	(0,57 - 0,90)
Nacional	**563**	**52.613.753**	**1,07**	**0,89**	**(0,82 - 0,97)**

[1] Incluye las muertes por todas las causas en la población con melanoma invasivo de la cohorte en seguimiento por la CAC.
[2] Corresponde a la población proyectada por el DANE para el año 2024.
[3] La mortalidad es informada por 100.000 habitantes.
[4] Estandarización por la edad calculada con método directo. La población de referencia correspondió a la estándar mundial por grupos quinquenales de edad, definida por la OMS.
[5] IC 95 % para las medidas estandarizadas.
IC: intervalo de confianza.

8.1.6. Mortalidad del melanoma según el régimen del aseguramiento y la entidad aseguradora

En la **tabla 8.7** se observa que el régimen contributivo alcanzó la cifra más alta de mortalidad general en los pacientes con melanoma. A su vez, dentro de las EAPB, el valor más bajo se presentó en la EPSI03, con 0,39 fallecimientos por 100.000 afiliados; mientras que las cifras más altas se presentaron en entidades del régimen especial (RES011, RES002, RES007), seguidas de la EAS27 con 1,76 muertes por 100.000 afiliados.

La información completa de las EAPB está disponible en HIGIA.

Tabla 8.7. Mortalidad general del melanoma según el régimen del aseguramiento, Colombia 2025

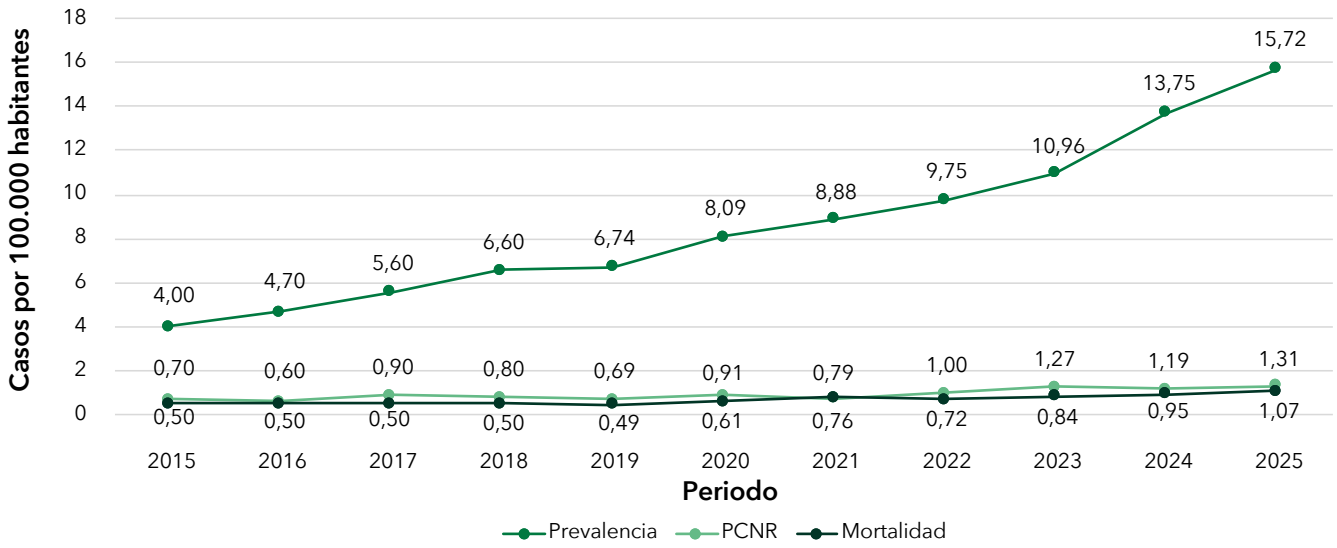
Régimen	Casos[1]	Denominador[2]	Mortalidad cruda[3]	Mortalidad estandarizada[3,4]	IC 95 %[5]
Contributivo	347	28.511.097	1,22	0,90	(0,81 - 1,00)
Subsidiado	189	20.558.122	0,92	0,70	(0,60 - 0,81)
Excepción	14	2.096.836	0,67	0,38	(0,20 - 0,69)
Especial	2	40.687	4,92	0,79	(0,09 - 28,95)
No asegurado	0	SD	SD	SD	SD
Planes voluntarios de salud	0	SD	SD	SD	SD
Entidades territoriales	11	SD	SD	SD	SD

[1] Incluye las muertes por todas las causas en la población con melanoma invasivo de la cohorte en seguimiento por la CAC.
[2] Corresponde a la población de la BDUA con corte al 30 de junio de 2024.
[3] Informada por 100.000 afiliados.
[4] Estandarización por la edad calculada con método directo. La población de referencia correspondió a la estándar mundial por grupos quinquenales de edad, definida por la OMS.
[5] IC 95 % para las medidas estandarizadas.
En la población no asegurada, los planes voluntarios de salud y las entidades liquidadas, no se cuenta con la información para establecer el denominador, por lo cual solamente se presenta el número de fallecidos notificados.
IC: intervalo de confianza; **SD:** sin dato.

8.1.7. Evolución del registro de melanoma en el aseguramiento en Colombia

Desde 2015, la prevalencia del melanoma en el país ha mostrado una tendencia creciente. En comparación con el primer periodo de seguimiento, para 2020 el número de casos prevalentes se había duplicado y, en el último periodo, fue cercano a cuatro veces el valor inicial. En 2025, en comparación con el 2024, se observó un incremento en la prevalencia del 14,33 %. De manera consistente, la PCNR aumentó un 10,08 % respecto al periodo anterior. Por su parte, la mortalidad presentó un incremento del 10,53 %.

Figura 8.1. Tendencia de las medidas de frecuencia del melanoma en el marco del aseguramiento, Colombia 2015 - 2025



Incluye los casos de melanoma invasivo de la cohorte en seguimiento por la CAC.
Las medidas presentadas corresponden a valores crudos, reportados por 100.000 habitantes.
Mortalidad: número de casos fallecidos por todas las causas de la cohorte en seguimiento por la CAC.
PCNR: proporción de casos nuevos reportados.

Descargar figura

8.2. Caracterización de los casos nuevos de melanoma

8.2.1. Características sociodemográficas de los casos nuevos de melanoma

La **tabla 8.8** presenta la caracterización general de los casos nuevos, *in situ* e invasivos de melanoma reportados en el periodo. El 77,37 % de estos casos se concentró en el régimen contributivo. En el país, 53 de cada 100 casos de este tipo de neoplasia fueron diagnosticados en las mujeres. A su vez, la mediana de la edad fue de 65 años (RIC: 53 - 75) y fue similar entre los regímenes del aseguramiento.

La mayoría de los CNR no pertenecía a ningún grupo étnico. Sin embargo, entre los casos identificados como población negra, la mayor proporción se encontraba afiliada al régimen contributivo. Por otro lado, cinco casos se identificaron como población indígena.

De otra parte, el 64,77 % de los CNR residía en Bogotá, D. C., y la región Central, mientras que en la Amazonía-Orinoquía y la Caribe se notificó el menor número de casos nuevos. Según el régimen del aseguramiento, los casos nuevos del contributivo se concentraron en estas mismas regiones del país; en cambio, en el subsidiado predominaron los residentes de las regiones Central, Oriental y Pacífica.

Tabla 8.8. Caracterización sociodemográfica de los casos nuevos de melanoma reportados según el régimen del aseguramiento, Colombia 2025

Variables[1]	Régimen del aseguramiento			Total[2]
	Contributivo	Subsidiado	Excepción	
	n= 872	n= 204	n= 45	n= 1.127
	(77,37 %)	(18,10 %)	(3,99 %)	(100,00 %)
Sexo				
Femenino	480 (55,05)	99 (48,53)	20 (44,44)	601 (53,33)
Masculino	392 (44,95)	105 (51,47)	25 (55,56)	526 (46,67)
Edad	64,5 (52 - 74)	68 (58 - 77)	68 (59 - 77)	65 (53 - 75)
Etnia				
Ninguna	857 (98,28)	201 (98,53)	45 (100,00)	1.109 (98,40)
Negro	12 (1,38)	0 (0,00)	0 (0,00)	12 (1,07)
Indígena	2 (0,23)	3 (1,47)	0 (0,00)	5 (0,44)
Otro[3]	1 (0,11)	0 (0,00)	0 (0,00)	1 (0,09)
Región de residencia				
Amazonía-Orinoquía	2 (0,23)	1 (0,49)	0 (0,00)	3 (0,27)
Bogotá, D. C.	339 (38,88)	22 (10,78)	14 (31,11)	375 (33,27)
Caribe	33 (3,78)	32 (15,65)	1 (2,22)	67 (5,94)
Central	279 (32,00)	55 (26,96)	19 (42,22)	355 (31,50)
Oriental	120 (13,76)	47 (23,04)	8 (17,78)	175 (15,53)
Pacífica	99 (11,35)	47 (23,04)	3 (6,67)	152 (13,49)

[1] Los valores reportados corresponden a frecuencias absolutas y relativas (n, %) para todas las variables, excepto la edad, para la que se presenta la mediana (rango intercuartílico).
[2] Para los valores totales se tienen en cuenta un caso reportado por los planes voluntarios de salud y cinco por el régimen especial.
[3] Incluye población perteneciente a las etnias ROM (gitano), raizal del Archipiélago de San Andrés y Providencia, y palenquero de San Basilio.

8.2.2. Caracterización clínica de los casos nuevos reportados de melanoma

La **tabla 8.9** presenta las características clínicas de los casos nuevos según el régimen del aseguramiento al sistema de salud. La distribución proporcional de los casos *in situ*, de acuerdo con el código CIE-10, fue similar a la observada en la estadificación por TNM dentro de cada régimen.

En el país, la estadificación se registró en el 80,66 % de los CNR y el 50,50 % de los estadificados correspondió a lesiones *in situ*. Al analizar los invasivos, el estadio I fue el más frecuente (17,82 %), comportamiento que también se observó en el régimen contributivo. En contraste, en el subsidiado, después de los *in situ*, el estadio II ocupó el segundo lugar de frecuencia. Por su parte, los estadios III y IV representaron el 29,37 % en el régimen subsidiado y el 14,19 % en el contributivo.

Tabla 8.9. Caracterización clínica de los casos nuevos de melanoma reportados según el régimen del aseguramiento, Colombia 2025

Variables[1]	Régimen del aseguramiento			Total[2]
	Contributivo	Subsidiado	Excepción	
	n= 872	n= 204	n= 45	n= 1.127
	(77,37 %)	(18,10 %)	(3,99 %)	(100,00 %)
Extensión[3]				
In situ	369 (42,32)	43 (21,08)	23 (51,11)	437 (38,78)
Invasivo	503 (57,68)	161 (78,92)	22 (48,89)	690 (61,22)
Estadificación (sí)[4]	719 (82,45)	154 (75,49)	34 (75,56)	909 (80,66)
Estadio al diagnóstico[4,5]				
In situ	385 (53,55)	48 (31,17)	24 (70,59)	459 (50,50)
Estadio I	137 (19,05)	21 (13,64)	4 (11,76)	162 (17,82)
Estadio II	95 (13,21)	39 (25,32)	3 (8,82)	137 (15,07)
Estadio III	59 (8,21)	29 (18,83)	3 (8,82)	91 (10,01)
Estadio IV	43 (5,98)	17 (11,04)	0 (0,00)	60 (6,60)

[1] Los valores reportados corresponden a frecuencias absolutas y relativas (n, %) para todas las variables.
[2] Para los valores totales se tienen en cuenta un caso reportado por los planes voluntarios de salud y cinco por el régimen especial.
[3] Definida según el código CIE-10.
[4] Definida según la clasificación TNM.
[5] Incluye los casos de melanoma que fueron estadificados.

8.2.3. Caracterización del tratamiento en los casos nuevos de melanoma

Del total de casos nuevos reportados (n= 1.127), el 70,28 % (n= 792) recibió algún tipo de tratamiento. Dentro de quienes fueron tratados, la mayoría correspondió a tumores *in situ*, sin embargo, este hallazgo debe interpretarse en un contexto en el que esta categoría también representó la mayor proporción de casos nuevos en el periodo.

En términos generales, el tratamiento quirúrgico fue la modalidad terapéutica más frecuente, seguido de la terapia sistémica y la radioterapia. Asimismo, según el estadio al diagnóstico, la cirugía predominó en los casos *in situ* y en los estadios I y II. En contraste, en el estadio III y IV, la terapia sistémica y el tratamiento quirúrgico fueron los tratamientos más indicados. Adicionalmente, aun con las limitaciones derivadas de la ausencia de la estadificación en el grupo de TNM desconocido, se observó que el tratamiento más frecuente para este grupo de casos fueron los procedimientos quirúrgicos, seguidos de la terapia sistémica y la radioterapia.

De los 335 CNR a quienes no se les prescribió ninguna opción terapéutica, 53 (15,82 %) habían sido diagnosticados dos meses antes de la fecha de corte, de los cuales el 58,49 % correspondió a tumores *in situ*, seguido de aquellos con estadificación desconocida (30,19 %). Asimismo, se identificó que, entre los casos sin tratamiento prescrito, siete fallecieron por cualquier causa dentro de los 90 días posteriores al diagnóstico.

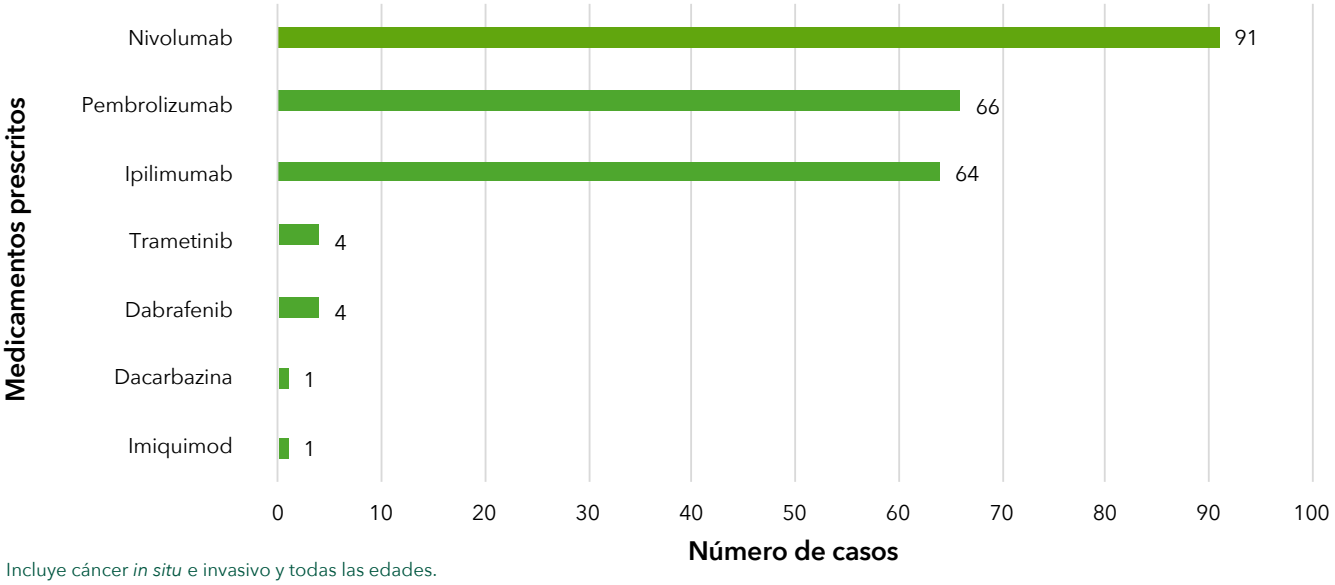
Tabla 8.10. Frecuencia del tratamiento prescrito en los casos nuevos de melanoma según el estadio clínico en el marco del aseguramiento, Colombia 2025

Variables[1]	Estadio al diagnóstico						
	In situ	Estadio I	Estadio II	Estadio III	Estadio IV	Desconocido	Total
	n= 459	n= 162	n= 137	n= 91	n= 60	n= 218	n= 1.127
	(40,73 %)	(14,37 %)	(12,16 %)	(8,07 %)	(5,32 %)	(19,34 %)	(100,00 %)
Casos que recibieron algún tratamiento	296 (64,49)	132 (81,48)	109 (79,56)	75 (82,42)	54 (90,00)	126 (57,80)	792 (70,28)
Tipo de tratamiento prescritos[2]							
Terapia sistémica[3]	0 (0,00)	6 (4,55)	38 (34,86)	48 (64,00)	44 (81,48)	24 (19,05)	160 (20,20)
Cirugía	288 (97,30)	132 (100,00)	106 (97,25)	55 (73,33)	17 (31,48)	108 (85,71)	706 (89,14)
Radioterapia	8 (2,70)	0 (0,00)	3 (2,75)	9 (12,00)	13 (24,07)	6 (4,76)	39 (4,92)

[1] Los valores reportados corresponden a frecuencias absolutas y relativas (n,%) para todas las variables.
[2] Las categorías de tratamiento no son mutuamente excluyentes; un mismo paciente pudo haber recibido más de un tipo de una terapia.
[3] En este grupo se incluyen la quimioterapia y otras terapias sistémicas.

La **figura 8.2** presenta los medicamentos administrados a las personas con diagnóstico reciente de melanoma. En los CNR predominó la inmunoterapia, particularmente los inhibidores de puntos de control inmunitario, entre los que se destacaron el nivolumab, el pembrolizumab y los anticuerpos contra el receptor CTLA-4, como lo es el ipilimumab. Esto es consistente con el manejo actual del melanoma, en el que uno de los esquemas empleados en la enfermedad avanzada consiste en la administración concomitante de nivolumab e ipilimumab durante una fase inicial, seguida del mantenimiento con nivolumab en monoterapia. En este contexto, la frecuencia de indicación de estos principios activos sugiere que dicho esquema estuvo entre los más utilizados en el 2025. Por su parte, el pembrolizumab también presentó una alta frecuencia de indicación y corresponde a otra de las inmunoterapias biológicas de uso habitual en el tratamiento de esta neoplasia como monoterapia.

Figura 8.2. Distribución de los medicamentos prescritos con mayor frecuencia en los casos nuevos de melanoma en el marco del aseguramiento, Colombia 2025



Incluye cáncer *in situ* e invasivo y todas las edades.

Descargar figura

8.3. Caracterización de los casos prevalentes de melanoma

La **tabla 8.11** presenta una caracterización general de los casos prevalentes de melanoma, tanto invasivo como *in situ*, según el régimen del aseguramiento en el periodo. De los 12.078 casos reportados, el 74,71 % se concentró en el régimen contributivo, seguido del 19,97 % en el subsidiado. En el país, el 59,88 % de los casos se presentó en las mujeres. Además, la distribución de la edad por régimen del aseguramiento fue similar a la observada en el país.

Entre los casos analizados, 158 (1,31 %) pertenecían a algún grupo étnico. De estos, el 55,70 % se identificó como parte de la comunidad negra y el 37,34 % de la indígena. A su vez, la mayoría de los casos de etnia negra se concentró en el régimen contributivo, mientras que en el subsidiado fue más frecuente la indígena.

La región Central concentró el 37,67 % de los casos prevalentes, lo que la ubicó como la región con el mayor número de casos, seguida de Bogotá, D. C., con el 27,70 %. Aunque la distribución territorial de los casos estuvo focalizada en algunas regiones, en el régimen subsidiado esta fue más dispersa. En el contributivo, el 69,61 % de los casos se concentró en dos regiones, Central y Bogotá, D. C.; mientras que, en el subsidiado, el 66,41 % se agrupó en tres regiones (la Central, la Pacífica y la Oriental).

Tabla 8.11. Caracterización sociodemográfica de los casos prevalentes de melanoma según el régimen del aseguramiento, Colombia 2025

Variables[1]	Régimen del aseguramiento					Total[2,3]
	Contributivo	Subsidiado	Excepción	Especial	Planes voluntarios de salud	
	n= 9.023	n= 2.412	n= 565	n= 48	n= 24	n= 12.078
	(74,71 %)	(19,97 %)	(4,68 %)	(0,40 %)	(0,20 %)	(100,00 %)
Sexo						
Femenino	5.359 (59,39)	1.514 (62,77)	321 (56,81)	22 (45,83)	13 (54,17)	7.232 (59,88)
Masculino	3.664 (40,61)	898 (37,23)	244 (43,19)	26 (54,17)	11 (45,83)	4.846 (40,12)
Edad	65 (54 - 75)	67 (57 - 77)	68 (59 - 76)	72 (64 - 76)	70 (66 - 76)	66 (55 - 76)
Etnia						
Ninguna	8.945 (99,14)	2.338 (96,93)	559 (98,94)	48 (100,00)	24 (100,00)	11.920 (98,69)
Negro	62 (0,69)	21 (0,87)	5 (0,88)	0 (0,00)	0 (0,00)	88 (0,73)
Indígena	9 (0,10)	50 (2,07)	0 (0,00)	0 (0,00)	0 (0,00)	59 (0,49)
Otra[4]	7 (0,08)	3 (0,12)	1 (0,18)	0 (0,00)	0 (0,00)	11 (0,09)
Región de residencia						
Amazonía-Orinoquía	27 (0,30)	71 (2,94)	7 (1,24)	0 (0,00)	0 (0,00)	105 (0,87)
Bogotá, D. C.	2.851 (31,60)	302 (12,52)	179 (31,68)	3 (6,25)	10 (41,67)	3.346 (27,70)
Caribe	298 (3,30)	291 (12,06)	45 (7,96)	0 (0,00)	1 (4,17)	635 (5,26)
Central	3.430 (38,01)	887 (36,77)	187 (33,10)	33 (68,75)	8 (33,33)	4.550 (37,67)
Oriental	1.336 (14,81)	413 (17,12)	95 (16,81)	3 (6,25)	3 (12,50)	1.850 (15,32)
Pacífica	1.081 (11,98)	448 (18,57)	52 (9,20)	9 (18,75)	2 (8,33)	1.592 (13,18)

[1] Los valores reportados corresponden a frecuencias absolutas y relativas (n, %) para todas las variables, excepto la edad, para la que se presenta la mediana (rango intercuartílico).
[2] Para los valores totales se tienen en cuenta seis casos de la población no asegurada.
[3] No se incluyeron los datos de 187 casos prevalentes que no se reportaron en el periodo actual porque pertenecen a entidades liquidadas.
[4] Incluye población perteneciente a las etnias ROM (gitano), raizal del Archipiélago de San Andrés y Providencia, y palenquero de San Basilio.

8.4. Indicadores de gestión del riesgo en melanoma

Los siguientes son los indicadores prioritarios para la medición, la evaluación y el monitoreo de la gestión del riesgo por parte de los aseguradores y de los prestadores en las personas con melanoma en Colombia (1):

1. Tiempo en que los pacientes con lesión sospechosa de melanoma son remitidos desde la atención primaria al dermatólogo/a u otro especialista competente en el tratamiento que define la conducta.
2. Tiempo entre la sospecha por médico general u otro profesional de la salud (remisión) ante la aparición de la lesión sospechosa de melanoma y la realización de la biopsia diagnóstica.
3. Tiempo entre la toma de la biopsia diagnóstica y la confirmación diagnóstica de melanoma.
4. Tiempo entre el diagnóstico histológico y el primer tratamiento.
5. Proporción de pacientes con biopsia por escisión.
6. Proporción de pacientes con informe histopatológico completo en el espécimen quirúrgico.
7. Proporción de pacientes con biopsia selectiva de ganglio centinela.
8. Proporción de pacientes con melanoma cutáneo con estadificación TNM.
9. Proporción de pacientes con melanoma cutáneo *in situ*.
10. Proporción de pacientes con melanoma cutáneo en estadios tempranos (I y II).
11. Proporción de pacientes con márgenes quirúrgicos adecuados de acuerdo con el tamaño tumoral (margen quirúrgico histopatológico) en melanoma temprano.

12.1. Proporción de pacientes con diagnóstico de melanoma que reciben tratamiento adyuvante para enfermedad temprana estadios IIC y III.

12.2. Proporción de pacientes con diagnóstico de melanoma que reciben tratamiento paliativo para enfermedad avanzada estadio IV.

13.1. Proporción de pacientes con diagnóstico de melanoma que reciben radioterapia como tratamiento adyuvante para enfermedad en estadio III.

13.2. Proporción de pacientes con diagnóstico de melanoma que reciben radioterapia como tratamiento paliativo para enfermedad en estadio IV.

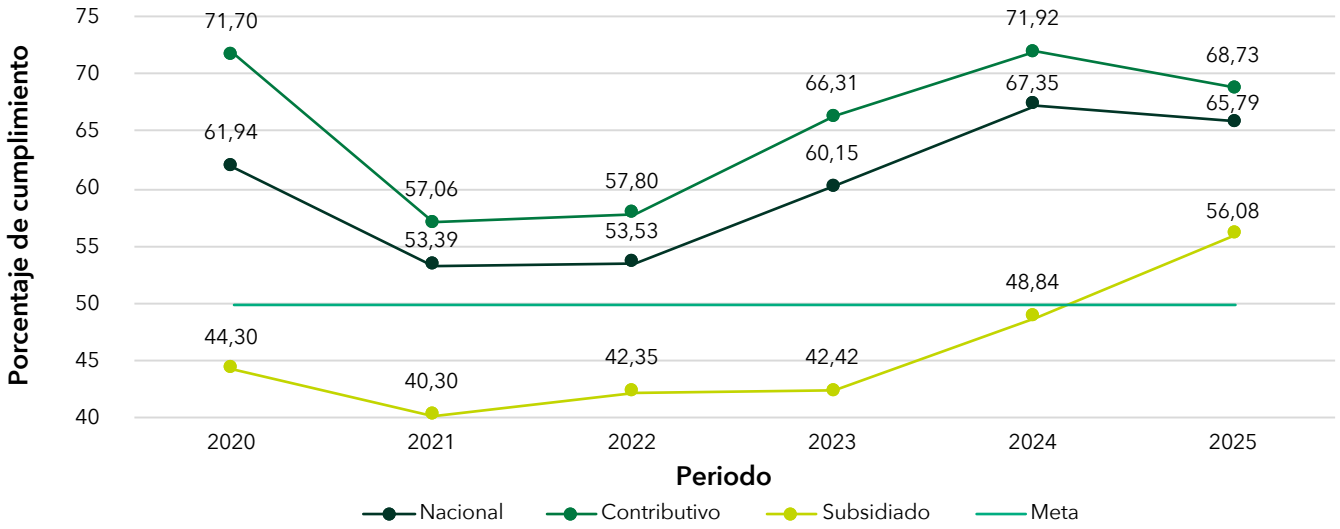
14. Proporción de pacientes que suspenden la terapia sistémica.
15. Proporción de pacientes con diagnóstico de melanoma en estadios III y IV a quienes se les realizó BRAF.
16. Proporción de pacientes incluidos en programas de cuidados paliativos (estadio IV).
17. Supervivencia global a 5 años.

Es de señalar que los indicadores 6, 7 y 11 no se estimaron para este periodo debido a que no se cuenta con las variables necesarias para su medición. Además, de acuerdo con la periodicidad de análisis establecida, para el indicador 19 se presentaron nuevas estimaciones en el periodo 2024 en un informe especial (2).

Puede consultar los datos de la gestión del riesgo con una mayor desagregación ingresando a HIGIA.

La proporción de casos de melanoma diagnosticados en estadios I y II ha sido variable en los últimos seis periodos. En el régimen subsidiado, esta proporción mostró una tendencia al aumento desde 2023 y, en comparación con 2024, registró un incremento relativo del 14,82 %. Por el contrario, en el país y en el régimen contributivo se observó una reducción frente al periodo previo del 2,32 % y 4,44 %, respectivamente. No obstante, en los tres escenarios el indicador se mantuvo superior al 50 %.

Figura 8.3. Tendencia de la proporción de los casos nuevos en estadios I y II en el momento del diagnóstico de melanoma cutáneo en el marco del aseguramiento, Colombia 2020 - 2025

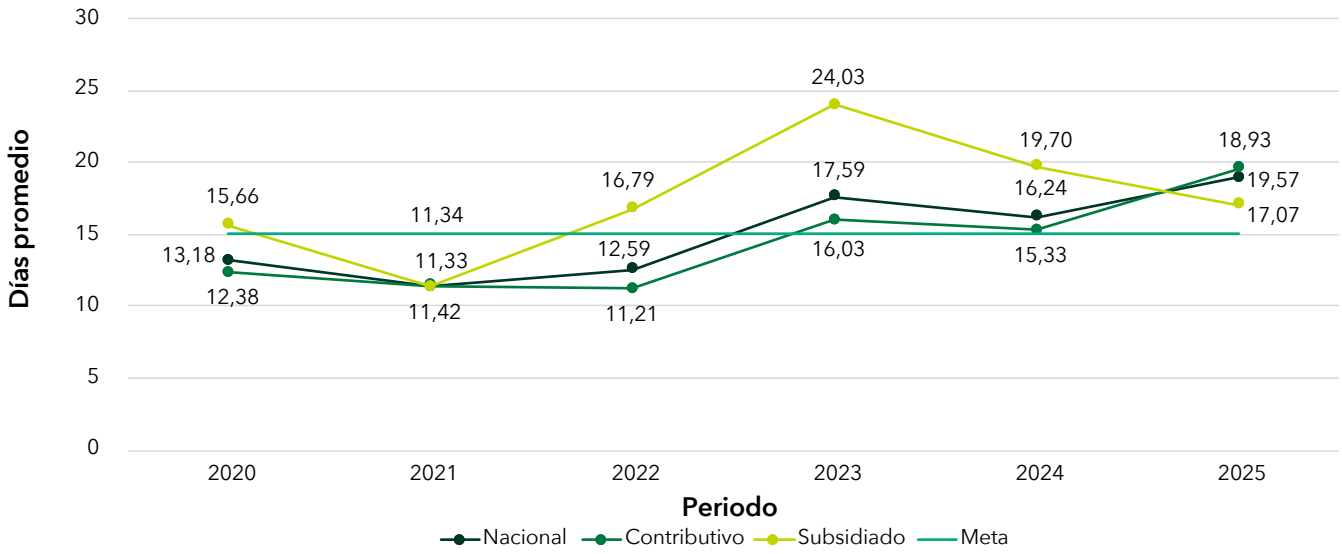


Incluye estadios I y II.

Descargar figura

La oportunidad diagnóstica del melanoma ha sido variable desde 2020. En el 2024, el indicador mostró una reducción en el país y en ambos regímenes del aseguramiento. Por su parte, en el 2025, el régimen subsidiado conservó la tendencia a la disminución de los tiempos de espera, registrando un promedio de 17,07 días para la confirmación diagnóstica; por el contrario, en el país y en el régimen contributivo se evidenció un incremento en el promedio de días, superando los días del subsidiado, pero con diferencias promedio menores a los 2 días.

Figura 8.4. Tendencia de la oportunidad de la confirmación diagnóstica de los casos nuevos de melanoma en el marco del aseguramiento, Colombia 2020 - 2025



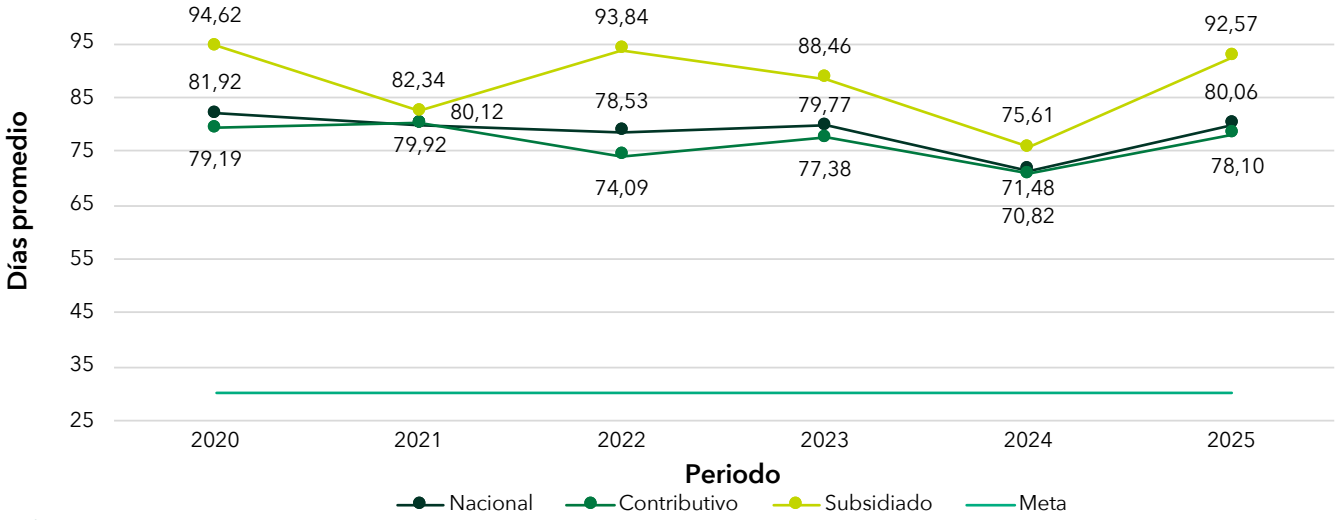
Oportunidad diagnóstica: tiempo entre la toma de la biopsia diagnóstica y la confirmación diagnóstica.
La media (desviación estándar) para la oportunidad del diagnóstico en el 2025 fue: de 18,93 días (± 17,32) en la medición nacional, de 19,57 días (± 18,19) en el régimen contributivo y de 17,07 días (± 13,07) en el subsidiado.
La mediana (rango intercuartílico) para la oportunidad del diagnóstico en el 2025 fue: de 14 días (RIC: 8 - 24) en la medición nacional, de 15 días (RIC: 9 - 25) en el régimen contributivo y de 13 días (RIC: 8 - 21) en el subsidiado.

Descargar figura

El acceso al tratamiento aún se encuentra alejado de la meta establecida (≤ 30 días). Los datos nacionales muestran un tiempo promedio de 80 días, con una espera un poco mayor en el subsidiado. En los últimos cinco periodos, en el país, no se observa un cambio en esta oportunidad.

Al analizar otros indicadores de oportunidad en la atención del melanoma en Colombia, el régimen subsidiado, en comparación con los resultados nacionales y los del contributivo, presentó menores tiempos en etapas clave del proceso diagnóstico, incluyendo la remisión desde la atención primaria al dermatólogo u otro especialista competente para definir la conducta terapéutica, el intervalo entre la sospecha clínica de melanoma y la realización de la biopsia diagnóstica, y el tiempo transcurrido entre la toma de la biopsia y la confirmación diagnóstica. Estos hallazgos sugieren que los principales desafíos en el régimen subsidiado no se presentan en la ruta diagnóstica, sino en la oportunidad de inicio del tratamiento, por lo que resulta prioritario fortalecer las estrategias orientadas a reducir los tiempos de acceso a las intervenciones terapéuticas.

Figura 8.5. Tendencia de la oportunidad del inicio del tratamiento de los casos nuevos de melanoma en el marco del aseguramiento, Colombia 2020 - 2025



Incluye casos *in situ* e invasivos.
Oportunidad de inicio del tratamiento: tiempo entre el diagnóstico histológico y el primer tratamiento.
La media (desviación estándar) para la oportunidad del tratamiento en el 2025 fue: de 80,06 días (± 55,54) en la medición nacional, de 78,10 días (± 52,81) en el régimen contributivo y de 92,57 días (± 67,77) en el subsidiado.
La mediana (rango intercuartílico) para la oportunidad del tratamiento en el 2024 fue: de 67 días (RIC: 38 - 105,5) en la medición nacional, de 65,50 días (RIC: 38 - 104) en el régimen contributivo y de 80 días (RIC: 37 - 128) en el subsidiado.

Descargar figura

En relación con los resultados de la gestión del riesgo según la región de residencia **(tabla 8.12),** el tiempo transcurrido entre la remisión desde la atención primaria y la valoración por dermatología u otra especialidad fue inferior a los 60 días en la región Amazonía-Orinoquía. En contraste, Bogotá, D. C., presentó la mayor espera frente a la meta establecida, con un promedio de días superior al observado en el país. Por su parte, el tiempo entre la sospecha clínica y la realización de la biopsia fue inferior a los 30 días tanto en el país como en todas las regiones.

El porcentaje de casos nuevos a los que se les realizó biopsia por escisión se ubicó por debajo del nivel mínimo de cumplimiento definido para este indicador, siendo la región Central la que presentó la proporción más alta con 27,89 %. La estadificación TNM en los casos nuevos superó el 90,00 % en la Amazonía-Orinoquía y Bogotá, D. C., mientras que la región Oriental registró la menor proporción de estadificación en el periodo analizado. En cuanto a la proporción de casos de melanoma cutáneo *in situ*, tanto en el país como en todas las regiones esta fue superior al 25,00 %, lo que corresponde a un nivel de cumplimiento alto.

Tabla 8.12. Indicadores de la gestión del riesgo en melanoma según la región de residencia en marco del aseguramiento, Colombia 2025

Número		1.	2.	3.	4.	5.	8	9.
Código[1]		MEL_01	MEL_02	MEL_03	MEL_04	MEL_05	MEL_08	MEL_09
Semaforización		≤ 60 días	≤ 30 días	≤ 15 días	≤ 30 días	> 90 %	> 90 %	> 25 %
		61 a 89 días	31 a 44 días	16 a 29 días	31 a 44 días	> 80 - 90 %	> 80 - 90 %	> 15 - 25 %
		≥ 90 días	≥ 45 días	≥ 30 días	≥ 45 días	≤ 80 %	≤ 80 %	≤ 15 %
Región	Amazonía-Orinoquía	19,00	0,00	15,00	121,00	0,00	100,00	33,33
	Bogotá, D. C.	84,51	19,64	19,79	81,07	15,47	85,07	66,14
	Caribe	79,23	21,90	29,25	75,61	26,87	68,66	26,09
	Central	68,63	11,19	16,36	74,45	27,89	81,41	41,87
	Oriental	83,75	19,16	19,85	103,55	16,57	78,29	42,34
	Pacífica	77,75	24,68	14,19	72,04	17,11	79,61	46,28
Nacional		**79,54**	**17,48**	**18,93**	**80,06**	**20,41**	**81,19**	**50,16**

Del total de casos nuevos de melanoma con diagnóstico histopatológico en el país, más del 50,00 % correspondió a estadios I y II. Esta proporción fue mayor en la región Caribe, donde alcanzó el 73,21 %.

En cuanto al manejo terapéutico, el 52,46 % de los CNR de melanoma en estadios IIC y III recibió terapia sistémica. En el análisis regional, Bogotá, D. C., y la región Pacífica presentaron un cumplimiento superior al 60,00 %. En los casos en estadio IV, la proporción que recibió este tipo de tratamiento fue mayor que la observada en los estadios IIC y III, con un resultado nacional del 73,33 %; nuevamente, Bogotá, D. C., registró la cifra más alta.

Respecto a la radioterapia, el 10,42 % de los CNR de melanoma en estadio III recibió este tratamiento en el país, con una mayor proporción en la región Oriental. En los pacientes con estadio IV, la proporción fue de 21,67 %; para este grupo, la región Pacífica alcanzó el mayor porcentaje de cumplimiento, con 37,50 %, por lo que superó al resto de las regiones.

En relación con la caracterización molecular, al 29,49 % de los casos nuevos diagnosticados en estadios III y IV se le verificó el estado de mutación BRAF. La región Pacífica presentó el mayor cumplimiento de este indicador (44,00 %); sin embargo, tanto el resultado nacional como los regionales se mantuvieron por debajo del umbral mínimo esperado (70,00 %). Según el régimen, el contributivo obtuvo un resultado del 32,35 % y el subsidiado del 26,09 %. Este hallazgo resulta relevante dada la importancia clínica de la determinación de la mutación BRAF como requisito previo para la definición del tratamiento sistémico en pacientes con enfermedad avanzada. En este contexto, el bajo cumplimiento del indicador puede limitar el acceso oportuno a terapias dirigidas y a una adecuada toma de decisiones terapéuticas, lo que evidencia la necesidad de fortalecer las acciones encaminadas a mejorar la oportunidad y cobertura de esta prueba diagnóstica.

Finalmente, en los CNR de melanoma en estadio IV, el cumplimiento nacional del indicador de atención en cuidado paliativo fue del 56,67 %, lo que evidencia un desempeño bajo. Para el cálculo de este indicador se considera la realización de consultas o procedimientos efectuados por profesionales médicos y no médicos en el marco de los cuidados paliativos. En este sentido, el indicador permite evaluar la incorporación de un enfoque paliativo como componente fundamental de la atención oncológica integral, orientado al control de síntomas, el mejoramiento de la calidad de vida y el acompañamiento del paciente durante el curso de la enfermedad. De otra parte, por regiones, la Central registró la mayor proporción de casos que recibieron esta atención (83,33 %), mientras que la Oriental presentó el menor cumplimiento (30,77 %), lo que pone de manifiesto importantes brechas territoriales en el acceso a este componente esencial del cuidado integral del cáncer.

Tabla 8.12. Indicadores de la gestión del riesgo en melanoma según la región de residencia en marco del aseguramiento, Colombia 2025 (continuación)

Número		10.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.
Código[1]		MEL_10	MEL_12_1	MEL_12_2	MEL_13_1	MEL_13_2	MEL_14	MEL_15	MEL_16
Semaforización		> 50 %	> 60 %	> 60 %	> 20 %	> 20 %	≤ 10 %	> 90 %	> 80 %
		> 40 - 50 %	> 40 - 60 %	> 40 - 60 %	> 15 - 20 %	> 15 - 20 %	> 10 - 19 %	> 70 - 90 %	> 60 - 80 %
		≤ 40 %	≤ 40 %	≤ 40 %	≤ 15 %	≤ 15 %	≥ 20 %	≤ 70 %	≤ 60 %
Región	Amazonía-Orinoquía	● 100,00	● 0,00	● 0,00	● 0,00	● 0,00	● 0,00	● 0,00	● 0,00
	Bogotá, D. C.	● 67,59	● 70,97	● 88,89	● 7,69	● 22,22	● 0,00	● 25,71	● 44,44
	Caribe	● 58,82	● 33,33	● 83,33	● 0,00	● 16,67	● 0,00	● 21,43	● 50,00
	Central	● 73,21	● 47,06	● 70,83	● 9,52	● 29,17	● 0,00	● 22,22	● 83,33
	Oriental	● 53,16	● 33,33	● 61,54	● 20,83	● 0,00	● 0,00	● 35,14	● 30,77
	Pacífica	● 61,54	● 70,00	● 75,00	● 5,88	● 37,50	● 0,00	● 44,00	● 37,50
Nacional		**● 65,79**	**● 52,46**	**● 73,33**	**● 10,42**	**● 21,67**	**● 0,00**	**● 29,49**	**● 56,67**

[1] Código del indicador en HIGIA.

Referencias bibliográficas

1. Cuenta de Alto Costo. Consenso basado en evidencia para la definición de indicadores de gestión del riesgo en pacientes con melanoma cutáneo en Colombia [en línea] 2020. Disponible en: https://cuentadealtocosto.org/publicaciones/consenso-basado-en-la-evidencia-para-la-definicion-de-indicadores-de-gestion-del-riesgo-en-pacientes-con-melanoma-cutaneo-en-colombia/
2. Cuenta de Alto Costo (CAC), Fondo Colombiano de Enfermedades de Alto Costo. Informe especial: Resultados de supervivencia global en las personas atendidas en el marco del sistema de salud colombiano y notificadas a la Cuenta de Alto Costo, 2014-2022; Bogotá, D. C. 2025. Disponible en: https://cuentadealtocosto.org/publicaciones/informe-de-supervivencia-2014-2022/